

Rúbrica de Evaluación de Convergencia Integral y Proyectiva

Instrumento unificado de evaluación clínica para la estructuración del plan de vida

5 Criterios Dominios independientes del psiquismo	Escala 1-3 Puntos por criterio evaluado
5-15 pts Rango total del instrumento	3 Categorías C · B · A con implicancias orientativas

1

Bloqueo

Categoría C · 5-8 pts

2

Transición

Categoría B · 9-12 pts

3

Autonomía

Categoría A · 13-15 pts

Propósito Clínico del Instrumento

Instrumento de evaluación unificada diseñado para medir el grado de convergencia entre los distintos dominios del psiquismo y la realidad concreta del sujeto, orientando de forma integral la estructuración del plan de vida.

Dominios Evaluados

- Autenticidad y congruencia existencial
- Regulación neurobiológica y urgencia sintomática
- Investidura libidinal y sentido proyectivo
- Viabilidad pragmática y sostén vincular
- Necesidades de autorrealización (Maslow)

Estructura del Instrumento

- **5 criterios independientes** con descriptores por nivel
- **Escala de 1 a 3 puntos** por criterio evaluado
- **Puntaje total:** 5 a 15 puntos
- **Tres categorías diferenciadas** (C, B, A) con implicancias orientativas específicas

Aplicación Clínica

Permite identificar el umbral de intervención adecuado antes de formular metas de orden superior, evitando planes proyectivos prematuros en contextos de vulnerabilidad profunda.

Criterio 1 — Autenticidad y Congruencia

1

Bloqueo • 1 pt

Subordinación total a mandatos externos ("debería" / "tengo que"); desconexión somática profunda con alexitimia; ausencia de autoría existencial.

2

Transición • 2 pts

Conciencia de la discrepancia vital pero limitada por culpa, miedo o parálisis; requiere espacios seguros de diferenciación para avanzar.

3

Vitalidad • 3 pts

Alta correspondencia entre valores internos y acciones cotidianas; el sujeto opera desde la autoría existencial con plena congruencia somático-cognitiva.

 **Indicadores clave a explorar:** Lenguaje de obligación vs. elección • Respuesta somática ante decisiones propias • Capacidad de identificar y nombrar estados afectivos • Historia de diferenciación de figuras de autoridad.

Criterio 2 — Regulación y Urgencia Sintomática

1

Bloqueo • 1 pt

Sintomatología ansiosa/depresiva predominante; alta carga alostática; sistema de recompensa inhibido; el síntoma ocupa el primer plano de la vida cotidiana.

2

Transición • 2 pts

El síntoma cede parcialmente o se resignifica como brújula orientadora; coexisten bloqueos cognitivos y hábitos arraigados que compiten con el cambio.

3

Vitalidad • 3 pts

Ausencia de sintomatología reactiva incapacitante; sentido claro de legado; procesamiento adaptativo de obstáculos con recursos de regulación autónoma consolidados.

 **Indicadores clave a explorar:** Frecuencia e intensidad de episodios sintomáticos • Calidad del sueño • Variabilidad de la frecuencia cardíaca • Capacidad de retorno al estado basal tras activación • Uso de estrategias de regulación.

Criterio 3 — Inversión Libidinal y Sentido

1

Bloqueo · 1 pt

Horizonte temporal colapsado en el presente inmediato; imposibilidad absoluta de planificar a mediano o largo plazo; anhedonia proyectiva.

2

Transición · 2 pts

Búsqueda incipiente de propósito; el síntoma funciona como brújula pero sin capacidad de sostener planes prolongados; motivación intermitente.

3

Vitalidad · 3 pts

Vitalidad proyectiva y trascendencia con despliegue creativo sostenido; metas complejas de autorrealización activas y en curso.

 **Indicadores clave a explorar:** Capacidad de imaginar el futuro con detalle · Presencia de proyectos personales activos · Experiencias de flujo o absorción · Narrativa de vida con sentido de continuidad y dirección.

Criterios 4 y 5 — Viabilidad Pragmática · Autorrealización

CRITERIO 4 — VIABILIDAD PRAGMÁTICA Y SOSTÉN

Bloqueo · 1 pt

Ausencia de recursos económicos/temporales autogestionados; entorno vincular boicoteador o dependiente que obstaculiza activamente el cambio.

Transición · 2 pts

Capacidades y deseos fragmentados; apoyos vinculares tibios o condicionados; dificultad para sostener agendas autónomas de forma consistente.

Vitalidad · 3 pts

Entorno facilitador activo; flexibilidad neurocognitiva conservada; alta autoeficacia con autorregulación emocional y red de sostén genuina.

Indicadores clave: Disponibilidad de tiempo y recursos económicos propios · Calidad del ecosistema relacional · Presencia de figuras de apoyo incondicional · Capacidad de establecer límites funcionales con el entorno.

CRITERIO 5 — AUTORREALIZACIÓN (MASLOW)

Bloqueo · 1 pt

Necesidades deficitarias básicas (seguridad, afiliación, supervisión) insatisfechas o amenazadas de base; la pirámide no tiene sustento.

Transición · 2 pts

Necesidades básicas cubiertas de forma elemental pero con estancamiento en estima o búsqueda de pertenencia; motivación de crecimiento bloqueada.

Vitalidad · 3 pts

Necesidades inferiores satisfechas de forma óptima; foco motivacional situado en la cúspide de la autorrealización con orientación al crecimiento y la trascendencia.

Sistema de Puntuación e Interpretación por Categorías

Categoría C · Bloqueo Deficitario

5–8 pts

Predominio de sintomatología severa, alta carga alostática, alienación por mandatos y fragilidad operativa. Todo plan proyectivo fracasará sin contención previa, modulación del estrés y deconstrucción de falsos selfs.

Categoría B · Transición y Clarificación

9–12 pts

Recursos latentes pero fragmentados; el paciente registra la discrepancia existencial. Umbral óptimo de convergencia clínica: se implementan "pasos posibles" y micro-ensayos de diferenciación.

Categoría A · Autonomía y Expansión

13–15 pts

Integración somática fluida, ecosistema relacional facilitador, alta autoeficacia y motivación intrínseca genuina. El proyecto fluye de forma autónoma con supervisión estratégica y mentoría psicológica.

Categoría	Rango	Interpretación Clínica	Implicancia Orientativa
C · Bloqueo	5–8 pts	Sintomatología severa, alta carga alostática, alienación por mandatos	Priorizar contención, regulación autónoma y deconstrucción de falsos selfs
B · Transición	9–12 pts	Recursos latentes fragmentados; síntoma como brújula; inercia competidora	Metodología de pasos posibles, micro-ensayos de diferenciación, agendas de acción
A · Autonomía	13–15 pts	Integración somática fluida, alta autoeficacia, motivación intrínseca genuina	Supervisión estratégica, mentoría psicológica, celebración de logros trascendentes

Implicancias Clínicas y Uso Orientativo del Instrumento

Principio rector: El puntaje no es un diagnóstico estático sino un mapa dinámico de convergencia; debe re-evaluarse periódicamente para ajustar el encuadre terapéutico.

Categoría C → Prioridad de Contención

Encuadre estricto de regulación del sistema autónomo, trabajo somático, deconstrucción de mandatos introyectados y fortalecimiento de la red de sostén **antes de cualquier planificación proyectiva.**

Categoría B → Andamiaje y Diferenciación

Implementar metodología de "pasos posibles", micro-ensayos de autonomía, negociación de límites con el entorno y construcción progresiva de agendas de acción sostenibles.

Categoría A → Expansión y Trascendencia

El espacio clínico acompaña mediante supervisión estratégica, mentoría psicológica y celebración de logros orientados a la trascendencia y el legado.

 **Advertencia metodológica:** Un puntaje alto en criterios aislados no compensa déficits severos en otros. La convergencia integral requiere que **ningún criterio se sitúe en Nivel 1 de forma crónica.**